

Dermatopatología — Guía de estudio

Dermatosis espongíóticas, psoriasiformes y pustulosas

Capítulo 6

Apuntes originales en español, redactados como material de estudio. No sustituyen al atlas ni a la observación directa de las preparaciones.

Índice

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → «Actualizar campos». También puedes navegar con el Panel de navegación (Vista → Panel de navegación).

Capítulo 6 — Dermatitis espongíóticas, psoriasiformes y pustulosas

Este capítulo reúne tres grandes patrones de reacción inflamatoria de la epidermis, definidos por su rasgo histológico dominante. La espongiosis es el edema intercelular (intraepidérmico) que separa los queratinocitos, ensancha los espacios intercelulares y estira los puentes intercelulares; cuando es intensa forma vesículas espongíóticas. El patrón psoriasiforme consiste en hiperplasia epidérmica regular con elongación de las crestas interpapilares. El patrón pustuloso se define por la acumulación de neutrófilos (o eosinófilos) formando pústulas intra o subcórneas.

Es importante asumir, desde el principio, una limitación diagnóstica esencial: muchas dermatitis espongíóticas son histológicamente inespecíficas y a menudo solo puede emitirse el diagnóstico de "dermatitis espongíótica compatible con eccema", siendo la correlación clínica imprescindible. La cronología de la lesión modifica el patrón: las lesiones agudas son muy espongíóticas, las subagudas combinan espongiosis y acantosis, y las crónicas son sobre todo psoriasiformes con hiperqueratosis (liquenificación).

Pistas útiles para afinar dentro de la espongiosis: la presencia de eosinófilos (dermatitis de contacto alérgica, reacciones a fármacos, penfigoide preampoloso, picaduras), de neutrófilos (psoriasis, infecciones, dermatitis seborreica), de paraqueratosis monticulada (dermatitis seborreica, pitiriasis rosada), de exocitosis linfocitaria atípica (micosis fungoide), o de afectación folicular/del acrosiringio. Reconocer estos detalles, junto con la distribución de la paraqueratosis y el grosor epidérmico, es la base del diagnóstico.

A. Dermatitis eccematosa (espongíótica)

Eccema y dermatitis espongíótica son sinónimos. Las lesiones más precoces son eritema y agregados de vesículas pruriginosas que se rompen y exudan; las crónicas se engruesan y descaman (liquenificación). Las manifestaciones dependen de la duración, la localización y el rascado. Clasificación etiológica en dermatitis endógena (factores constitucionales/hereditarios) y exógena (factores ambientales).

Dermatitis endógena

Dermatitis atópica (Atopic dermatitis)

Clínica: Puede empezar a cualquier edad, habitualmente desde la 6.^a semana de vida; curso crónico y recidivante. Fase infantil: cabeza, cara, cuello, zona del pañal y superficies de extensión. En el niño mayor se desplaza a flexuras. Prurito intenso, liquenificación, xerosis; mayor riesgo de infección bacteriana, dermatofítica y vírica (eccema herpético).

Histopatología: Espongiosis variable (más en agudas) con acantosis e hiperqueratosis/paraqueratosis en crónicas; infiltrado linfocítico perivascular superficial con eosinófilos variables. En lesiones liquenificadas, patrón psoriasiforme con fibrosis papilar vertical (colágeno en haces verticales).

Dermatitis seborreica (Seborrheic dermatitis)

Clínica: Placas eritematoescamosas grasientas en zonas seborreicas (cuero cabelludo, surcos nasogenianos, cejas, región preesternal); asociada a *Malassezia*. Frecuente y a veces extensa en VIH y en parkinsonismo.

Histopatología: Combinación de rasgos espongíóticos y psoriasiformes con un hallazgo orientador: paraqueratosis "en hombro" o montículos de paraqueratosis en los bordes de los orificios foliculares (paraqueratosis folicular/perifolicular), a menudo con neutrófilos y costra serosa. Acantosis leve.

Dermatitis discoide (eccema numular) (Discoid dermatitis (nummular eczema))

Clínica: Placas eccematosas redondeadas ("en moneda"), exudativas, en extremidades; muy pruriginosas.

Histopatología: Dermatitis espongíótica subaguda/crónica con espongiosis, acantosis, paraqueratosis y costra serosa con neutrófilos; infiltrado con eosinófilos. Inespecífica.

Eccema de manos (dishidrótico, palmoplantar, ponfólix) (Hand eczema (dyshidrotic eczema, palmoplantar, pompholyx))

Clínica: Vesículas profundas, tensas, "en grano de arroz", muy pruriginosas, en palmas, plantas y caras laterales de los dedos (ponfólix); el grueso estrato córneo atrapa el líquido.

Histopatología: Vesículas espongíóticas intraepidérmicas grandes bajo un estrato córneo compacto y grueso; espongiosis y exocitosis linfocitaria. La acral suele ser muy edematosa.

Reacción de autosensibilización (reacción ide) (Autosensitization (Id) reaction)

Clínica: Erupción eccematosa diseminada secundaria/a distancia de un foco inflamatorio o infeccioso (p. ej., dermatofitosis, dermatitis de estasis); fenómeno de hipersensibilidad.

Histopatología: Dermatitis espongíótica inespecífica.

Dermatitis exógena

Dermatitis de contacto (Contact dermatitis)

Clínica: Dos grandes formas: irritativa (por daño tóxico directo, no inmunológica, restringida a la zona de contacto) y alérgica (hipersensibilidad tipo IV retardada, que puede extenderse fuera del área de contacto y recurrir con la reexposición). Patrón geométrico/lineal sugerente.

Histopatología: Dermatitis espongíótica con eosinófilos en la dermis y, a veces, en la epidermis (espongiosis eosinofílica), especialmente en la alérgica; en la irritativa puede haber necrosis de queratinocitos y neutrófilos. No es posible distinguir con fiabilidad irritativa de alérgica solo por la histología.

Dermatitis infectiva (Infective dermatitis)

Clínica: Eccema asociado a infección bacteriana crónica (clásicamente en niños portadores de HTLV-1); exudación y costras.

Histopatología: Dermatitis espongíótica con costra y abundantes neutrófilos.

Dermatitis asteatósica (Asteatotic dermatitis (eczema craquelé))

Clínica: Piel seca, fisurada en patrón "de cuarteado" o "lecho de río seco" (eczema craquelé), en piernas de ancianos en invierno.

Histopatología: Espongiosis leve con hiperqueratosis compacta y disminución del contenido lipídico; inespecífica.

Liquen simple crónico (Lichen simplex chronicus)

Clínica: Placa liquenificada, engrosada, con acentuación de los pliegues cutáneos, en zonas de rascado/roce crónico (nuca, tobillos, área genital).

Histopatología: Hiperplasia epidérmica psoriasiforme compacta e irregular, hiperqueratosis, hipergranulosis y fibrosis vertical de la dermis papilar (haces de colágeno perpendiculares) — el sello del rascado crónico.

Prurigo nodular y nódulo de prurigo (Nodular prurigo and prurigo nodule)

Clínica: Nódulos firmes, hiperqueratósicos y muy pruriginosos, en superficies de extensión, por rascado intenso y repetido.

Histopatología: Hiperplasia epidérmica pseudoepiteliomatosa marcada con hiperqueratosis, fibrosis dérmica vertical y, a veces, hiperplasia neural; infiltrado con eosinófilos.

Dermatitis de estasis y acroangiodermatitis (Stasis dermatitis and acroangiodermatitis)

Clínica: En piernas con insuficiencia venosa crónica: eccema, hiperpigmentación (hemosiderina), induración (lipodermatosclerosis). La acroangiodermatitis (pseudo-Kaposi) cursa con pápulas violáceas por proliferación vascular reactiva.

Histopatología: Espongiosis leve con proliferación de capilares de pared gruesa en la dermis papilar, extravasación de hematíes y depósitos de hemosiderina (siderófagos); fibrosis. La proliferación vascular lobulillar de la acroangiodermatitis simula sarcoma de Kaposi pero es HHV-8 negativa.

Pitiriasis alba (Pityriasis alba)

Clínica: Máculas hipopigmentadas mal definidas con fina descamación, en mejillas de niños; variante de atopia.

Histopatología: Espongiosis leve, hiperqueratosis y disminución de la melanina basal.

Prúrigo actínico (Actinic prurigo)

Clínica: Fotodermatosis crónica pruriginosa en zonas fotoexpuestas (cara, labios), frecuente en poblaciones amerindias; queilitis y conjuntivitis.

Histopatología: Dermatitis espongíótica con infiltrado linfocítico; la afectación labial puede mostrar folículos linfoides.

Espongiosis eosinofílica (Eosinophilic spongiosis)

Concepto: Patrón histológico (no una enfermedad) de espongiosis con abundantes eosinófilos intraepidérmicos. Diagnóstico diferencial: penfigoide ampoloso/gestacional preampoloso, pénfigo (vegetante/herpetiforme), dermatitis de contacto alérgica, picaduras, incontinencia pigmentaria (fase vesicular) y reacciones a fármacos.

Eritrodermia (Erythroderma)

Clínica: Eritema y descamación que afectan a >90 % de la superficie corporal; causas: eccema, psoriasis, reacciones a fármacos, linfoma cutáneo de células T (síndrome de Sézary), pitiriasis rubra pilaris e idiopática.

Histopatología: A menudo inespecífica (espongiosis o psoriasiforme); obliga a correlación clínica y a descartar linfoma (buscar atipia linfocitaria y epidermotropismo).

Síndrome de Sulzberger-Garbe (Sulzberger-Garbe syndrome)

Clínica: Dermatitis exudativa discoide y liquenoide pruriginosa; entidad clásica de definición discutida.

Dermatitis del sitio de injerto venoso (Vein graft site dermatitis)

Clínica: Dermatitis eccematosa sobre la cicatriz de extracción de vena safena (p. ej., tras bypass coronario).

Acrodermatitis papular de la infancia (síndrome de Gianotti-Crosti) (Papular acrodermatitis of childhood)

Clínica: Erupción papular simétrica en mejillas, nalgas y superficies de extensión de extremidades en niños pequeños, tras infecciones víricas (clásicamente hepatitis B, hoy más a menudo VEB y otros).

Histopatología: Espongiosis leve con infiltrado linfocítico perivascular; inespecífica.

Pitiriasis rosada (Pityriasis rosea)

Clínica: Placa "heraldo" inicial seguida, a los días, de erupción de pápulas y placas ovaladas con collarite descamativo, distribuidas "en árbol de Navidad" en el tronco; autolimitada. Asociada a reactivación de HHV-6/7.

Histopatología: Espongiosis focal con paraqueratosis "en montículos", exocitosis linfocitaria, extravasación de hematíes en la dermis papilar y disqueratosis ocasional; infiltrado superficial.

Dermatosis plantar juvenil (Juvenile plantar dermatosis)

Clínica: Eritema brillante, descamación y fisuras en la zona de apoyo plantar de niños, por oclusión/fricción con calzado; respeta los espacios interdigitales.

Histopatología: Espongiosis centrada en el acrosiringio (conducto ecrino) con psoriasiforme leve.

Miliaria (Miliaria)

Clínica: Obstrucción del conducto ecrino: miliaria cristalina (vesículas subcórneas claras), miliaria rubra (pápulo-vesículas eritematosas, "sudamina") y miliaria profunda. Por calor y oclusión.

Histopatología: Vesícula y espongiosis centradas en el acrosiringio; en la cristalina, vesícula intracórnea/subcórnea sobre el conducto; en la rubra, espongiosis periductal con infiltrado.

Enfermedad de Fox-Fordyce (Fox-Fordyce disease)

Clínica: Pápulas foliculares pruriginosas en zonas con glándulas apocrinas (axilas) por obstrucción del conducto apocrino, en mujeres jóvenes.

Histopatología: Tapón de queratina del infundíbulo con espongiosis del conducto apocrino e infiltrado; los "queratinocitos espumosos" perifoliculares (vacuolas) son una pista descrita.

Dermatosis acantolítica transitoria con afectación del conducto ecrino (Transient acantholytic dermatosis with prominent eccrine ductal involvement)

Concepto: Variante de la dermatosis acantolítica transitoria (Grover) en la que la acantólisis/disqueratosis se centra de forma llamativa en los conductos ecrinos.

B. Dermatosis psoriasiformes

El patrón psoriasiforme se define por la hiperplasia epidérmica regular con elongación de las crestas. El prototipo es la psoriasis, pero comparten patrón el liquen simple crónico, la pitiriasis rubra pilaris, la dermatitis crónica, el síndrome de Reiter, la micosis fungoide y algunas infecciones.

Psoriasis (Psoriasis)

Clínica: Placas eritematosas bien delimitadas con escama plateada en superficies de extensión (codos, rodillas), cuero cabelludo y región sacra; fenómeno de Koebner; signo de Auspitz (sangrado puntiforme al desprender la escama). Variantes: en placas (vulgar), guttata (postestreptocócica), invertida, eritrodérmica y pustulosa (generalizada de von Zumbusch, palmoplantar). Asociación con artritis psoriásica y síndrome metabólico.

Histopatología (placa establecida): Hiperplasia psoriasiforme regular con crestas elongadas y adelgazamiento suprapapilar; paraqueratosis confluyente con neutrófilos en el estrato córneo (microabscesos de Munro) y en la capa espinosa superior (pústulas espongiiformes de Kogoj); hipogranulosis; capilares dilatados y tortuosos en las papilas dérmicas elongadas (correlato del signo de Auspitz). En lesiones precoces, paraqueratosis monticulada, dilatación capilar y escasos neutrófilos.

Variantes histológicas: Psoriasis pustulosa: pústulas espongiiformes grandes con escasa acantosis. Guttata: cambios más sutiles, paraqueratosis focal. Eritrodérmica: a menudo inespecífica.

Síndrome de Reiter (Reiter's syndrome (artritis reactiva))

Clínica: Tríada de artritis, uretritis y conjuntivitis tras infección genitourinaria o digestiva; lesiones cutáneas: queratoderma blenorragico (placas hiperqueratósicas pustulosas en palmas y plantas) y balanitis circinada.

Histopatología: Indistinguible de la psoriasis pustulosa: hiperplasia psoriasiforme con pústulas espongiiformes y marcada hiperqueratosis/paraqueratosis.

Pitiriasis rubra pilaris (Pityriasis rubra pilaris)

Clínica: Placas anaranjadas con islotes de piel respetada ("islands of sparing"), pápulas foliculares queratósicas (cono de queratina folicular), queratodermia palmoplantar amarillenta ("en sandalia") y tendencia a la eritrodermia. Formas familiar (CARD14) y adquirida.

Histopatología: Hiperplasia psoriasiforme con ortoqueratosis y paraqueratosis alternantes en damero ("checkerboard", horizontal y vertical), tapones foliculares con paraqueratosis en los "hombros" del folículo, hipergranulosis focal y ausencia (o escasez) de neutrófilos (a diferencia de la psoriasis).

Nevo epidérmico verrugoso inflamatorio lineal (NEVIL) (Inflammatory linear verrucous epidermal nevus (ILVEN))

Clínica: Placa lineal verrugosa, pruriginosa e inflamatoria que sigue las líneas de Blaschko, presente desde la infancia; resistente al tratamiento.

Histopatología: Patrón psoriasiforme con alternancia muy característica de zonas de ortoqueratosis con hipergranulosis y zonas de paraqueratosis con agranulosis, dispuestas en columnas adyacentes.

Síndrome de Bazex (Bazex syndrome (acroqueratosis paraneoplásica))

Clínica: Acroqueratosis paraneoplásica: placas psoriasiformes violáceas en acras (orejas, nariz, dedos) asociadas a carcinoma de vías aerodigestivas superiores. (No confundir con el síndrome de Bazex-Dupré-Christol, que es una genodermatosis distinta.)

Histopatología: Psoriasiforme inespecífica con paraqueratosis; el contexto clínico/oncológico es la clave.

C. Dermatosis pustulosas

Se caracterizan por colecciones de neutrófilos (o eosinófilos) intra o subcórneas. El diagnóstico diferencial incluye la psoriasis pustulosa (ya tratada), las pustulosis por fármacos, la dermatosis

pustulosa subcórnea y un grupo de pustulosis neonatales/infantiles. La tinción de Gram y los cultivos ayudan a descartar causa infecciosa.

Reacciones pustulosas por fármacos (PEGA/AGEP) (Pustular drug reactions (acute generalized exanthematous pustulosis))

Clínica: Pustulosis exantemática aguda generalizada (PEGA/AGEP): erupción brusca de decenas de pústulas estériles pequeñas sobre base eritematosa, con fiebre y neutrofilia, días después de iniciar un fármaco (a menudo antibióticos); resolución al retirarlo.

Histopatología: Pústulas subcórneas y/o intraepidérmicas espongiformes con edema de la dermis papilar, eosinófilos en el infiltrado (pista frente a la psoriasis pustulosa) y, a veces, queratinocitos necróticos y vasculitis leucocitoclástica leve.

Dermatosis pustulosa subcórnea (de Sneddon-Wilkinson) (Subcorneal pustular dermatosis)

Clínica: Pústulas flácidas que muestran nivel líquido (mitad superior de pus) en distribución anular/serpiginosa en pliegues y tronco; curso crónico recurrente. Asociación con gammapatía monoclonal IgA.

Histopatología: Pústula subcórnea de neutrófilos justo bajo el estrato córneo, con acantólisis mínima o ausente y escasa espongiosis; epidermis subyacente poco alterada. Hay que diferenciarla del pénfigo por IgA tipo subcórneo (IFD con IgA intercelular).

Eritema tóxico del neonato (Toxic erythema of the neonate)

Clínica: Máculas eritematosas con pápulas y pústulas en recién nacidos sanos durante los primeros días; benigno y autolimitado.

Histopatología: Pústula subcórnea/intraepidérmica centrada en el folículo con abundantes eosinófilos.

Acropustulosis infantil (Infantile acropustulosis)

Clínica: Brotes recurrentes de vesículo-pústulas muy pruriginosas en manos y pies de lactantes; puede seguir a una sarna.

Histopatología: Pústula intraepidérmica/subcórnea rica en neutrófilos (a veces eosinófilos).

Melanosis pustulosa neonatal transitoria (Transient neonatal pustular melanosis)

Clínica: Pústulas presentes ya al nacer que se rompen dejando un collarite escamoso y máculas hiperpigmentadas residuales; más frecuente en neonatos de piel oscura; benigna.

Histopatología: Pústula subcórnea/intracórnea con neutrófilos; las lesiones tardías muestran hiperpigmentación basal.

Foliculitis pustulosa eosinofílica de la infancia (Eosinophilic pustular folliculitis of infancy)

Clínica: Pústulas foliculares recurrentes en cuero cabelludo de lactantes (variante infantil de la enfermedad de Ofuji); benigna. En adultos se asocia a inmunosupresión (VIH).

Histopatología: Foliculitis con abundantes eosinófilos centrada en el infundíbulo y la glándula sebácea, con espongiosis eosinofílica folicular.

Tablas de alto rendimiento

Tabla — Pistas dentro de la dermatitis espongiforme

Pista histológica	Orienta a
Eosinófilos prominentes	Contacto alérgico, fármacos, penfigoide preampolloso, picaduras
Neutrófilos / costra serosa	Dermatitis seborreica, infecciosa, psoriasis

Paraqueratosis "en hombro" perifolicular	Dermatitis seborreica
Paraqueratosis en montículos + hematíes extravasados	Pitiriasis rosada
Espongiosis centrada en acrosiringio	Dermatosis plantar juvenil, miliaria
Fibrosis papilar vertical	Liquen simple crónico, prurigo nodular
Hemosiderina + capilares de pared gruesa	Dermatitis de estasis

Tabla — Psoriasis vs Pitiriasis rubra pilaris

Rasgo	Psoriasis	Pitiriasis rubra pilaris
Paraqueratosis	Confluente, con neutrófilos	Alternante en damero (orto/para)
Capa granular	Reducida/ausente	Conservada o focalmente aumentada
Neutrófilos (Munro/Kogoj)	Presentes	Ausentes o escasos
Folículos	Sin tapón típico	Tapón folicular con paraqueratosis "en hombro"
Clínica	Escama plateada, Auspitz	Islotes de piel respetada, QPP anaranjada

Tabla — Pustulosis: nivel y pista

Entidad	Nivel de la pústula	Pista / asociación
Psoriasis pustulosa	Espongiforme (Kogoj)	Hiperplasia psoriasiforme, neutrófilos
AGEP (fármacos)	Subcórnea/ intraepidérmica	Eosinófilos, edema papilar, inicio brusco
Sneddon-Wilkinson	Subcórnea	Nivel líquido; gammapatía IgA
Pénfigo IgA subcórneo	Subcórnea	IFD: IgA intercelular
Eritema tóxico neonatal	Subcórnea folicular	Eosinófilos; neonato sano
Melanosis pustulosa neonatal	Subcórnea	Neutrófilos; hiperpigmentación residual

Glosario bilingüe (inglés → español)

Término (EN)	Español	Nota
Spongiosis	Espongiosis	Edema intercelular intraepidérmico
Acanthosis	Acantosis	Engrosamiento de la capa espinosa
Psoriasiform hyperplasia	Hiperplasia psoriasiforme	Crestas elongadas regulares
Parakeratosis	Paraqueratosis	Núcleos retenidos en el córneo
Mounds of parakeratosis	Montículos de paraqueratosis	Pitiriasis rosada, seborreica
Munro microabscess	Microabsceso de Munro	Neutrófilos en el córneo (psoriasis)
Spongiform pustule of Kogoj	Pústula espongiforme de Kogoj	Neutrófilos en espinosa alta (psoriasis)
Suprapapillary thinning	Adelgazamiento suprapapilar	Sobre las papilas en psoriasis
Exocytosis	Exocitosis	Migración de células inflamatorias a la epidermis
Vertical (papillary) fibrosis	Fibrosis papilar vertical	Liquen simple crónico/prúrigo
Checkerboard parakeratosis	Paraqueratosis en damero	Pitiriasis rubra pilaris
Acrosyringium	Acrosiringio	Porción intraepidérmica del conducto ecrino
Eosinophilic spongiosis	Espongiosis eosinofílica	Patrón con varios DDx
Lichenification	Liquenificación	Engrosamiento por rascado crónico
Subcorneal pustule	Pústula subcórnea	Bajo el estrato córneo

Nota: documento de elaboración propia con fines de estudio.